

К СПОРТ-ТРАВМАТОЛОГУ · 17.07

Прочитать перед приёмом · цель — уйти с конкретикой, не с «поберегитесь»

1 Скажи первым — этого нет в их системе

- **Цель:** Gauja 90 км / **2200 м набора** / 1 августа — через **15 дней** после приёма.
- **Причина травмы** — скачки набора высоты, не техника: недельный D+ прыгал 400→1019→857 м на неадаптированном тендоне; триггер — глубокий присед 08.07.
- **Сейчас:** боль ~1/10 на покое (6 дней без бега) — но УЗИ того же дня показывает активное воспаление. Боль ушла от разгрузки, не от заживления.

УЗИ 15.07 КРАТКО

Правый ахилл, средне-дистальная 1/3 — **выраженный активный тендинит + перитендинит**, неоваскуляризация. **Ретрокальканеальный бурсит** (жидкость до 5 мм), отёк жира Кагера. Подошвенная фасция до 5 мм. **Разрывов и кальцинатов нет**, связки целы.

2 Вытащи конкретику — с чем уйти

- Прямой **go / no-go по Gauja** — и если «условно», по каким критериям и к какой дате.
- **Схема возврата к бегу** с вехами: когда первый бег, какой тест открывает каждый шаг.
- Что **можно грузить сейчас**: вело/бассейн — ок? какие силовые безопасны?
- **Бурсит/перитендинит** отдельно: каблучок, обувь, надо ли что-то местно.
- Срок, за который **осядет активное воспаление** — влезает ли в 15 дней.
- Направление к **физио** + конкретный протокол ЛФК.

3 · Неудобный вопрос в лоб

«Если бы это была ваша нога — вышли бы на старт 90к? И что худшее, если я выйду и на дистанции сорвёт?»

Спортивный врач хеджирует — вытащи честный ответ, а не вежливый. После приёма — вердикт и схему мне, пересоберём тренировки и решение по Gauja.